Id pgMED: 31691840
ID archiwalne: EAR_RIS: R4N31691840

LUX MED Sp. z o.o. 02-676 Warszawa Postępu 21 C
NIP 527-252-30-80 , REGON 14072360300022
(V cz. kodu 109) LUX MED Diagnostyka
Pracownia rezonansu magnetycznego , VII cz. kodu 2519 , VIII cz.kodu 7250 - Pracownia rezonansu magnetycznego
02-801 WARSZAWA PUŁAWSKA 455
tel: (22) 880 90 80
Nr księgi rejstrowej 000000007392
KRS 0000265353 , Kapitał zakładowy 544728500
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nazwisko i imię: PODNIESIŃSKI MICHAŁ **Data urodzenia:** 15-08-1988
Adres: 02-791 WARSZAWA, Meander 7 m. 39 **PESEL:** 88081509290

WARSZAWA , dn. 18-09-2020

MR - Rezonans magnetyczny stawu kolanowego

z dn. 16-09-2020

Badanie wykonano aparatem: MR Siemens MAGNETOM Avanto 1,5
Lekarz zlecający: lek. med. JERZY BOROWIEC PWZ:1284924

Rozpoznanie ze skierowania

Dane kliniczne ze skierowania

Dolegliwości pr. kolana. W wieku 10 lat miał skręcone kolano, gips na mc.
Bolesność palpac. jak plica+ ból szpary MM

Opis badania radiologicznego

Wykonano jednofazowe badanie MR prawego stawu kolanowego w obrazach T1, T2 i PD zależnych, w płaszczyznach poprzecznych, strzałkowych i czołowych.
Ilość płynu w jamie stawowej nieco zwiększona.
Stan po zwichnięciu rzepki - lateralizacja rzepki o około 9mm, niezbyt silny obrzęk w dolno-przyśrodkowej części rzepki i bocznej części LFC. Całkowite lub prawie całkowite zerwanie MPFL przy przyczepie udowym, uszkodzenie II stopnia przy przyczepie rzepkowym. MPFL na całej długości otoczony nasilonym obrzękiem.
TT-TG = 19mm. Wsp. I-S = 1.07.
Zmiany chondromalacyjne II/III stopnia w przyśrodkowej części powierzchni stawowej rzepki o wym. 22x17mm. Chrząstka powierzchni rzepkowej kości udowej gładka, bez zmian w warstwie podchrzęstnej.
Obraz więzadła i troczka bocznego rzepki oraz ścięgna mięśnia czworogłowego uda niezmieniony.
Obrzęk w górno-przyśrodkowej części ciała tłuszczowego Hoffy.
Obrzęk w podskórnej tk. tłuszczowej w okolicy przedrzepkowej i przedpiszczelowej.

Fałdy błony maziowej niepogrubiałe.
Więzadła krzyżowe o zachowanej ciągłości, gładkich zarysach i typowym sygnale.
Kość piszczelowa bez cech istotnego podwichnięcia.
Obie łąkotki typowo położone, o gładkich zarysach i niezmienionym sygnale.
Chrząstki stawowe w przedziale bocznym i przyśrodkowym bez cech zaawansowanej chondromalacji ani pourazowego uszkodzenia i bez zmian w warstwie podchrzęstnej.
MCL o gładkich zarysach, niepogrubiałe, o niezmienionym sygnale, otoczone obrzękiem z powodu uszkodzenie MPFL. Obraz ścięgien mięśni tworzących gęsią stopkę oraz mięśnia półbłoniastego i głowy przyśrodkowej mięśnia trójgłowego w zakresie objętym badaniem niezmieniony. Niewielki wysięk w kaletce brzuchato-półbłoniastej 18x5x34mm.
LCL o gładkich zarysach, niepogrubiałe, o niezmienionym sygnale. Obraz pasma biodrowo-piszczelowego oraz ścięgna mięśnia podkolanowego, mięśnia dwugłowego uda i głowy bocznej mięśnia trójgłowego w zakresie objętym badaniem niezmieniony.

Wnioski

Stan po zwichnięciu rzepki. MPFL wydaje się zerwane przy przyczepie udowym. Poza tym jak w opisie.

Lekarz nadzorujący:

Przygotował(a):
dr n.med. PIOTR GĘBSKI
Zatwierdził(a):
dr n.med. PIOTR GĘBSKI

Podpisał(a) dnia 18-09-2020 dr n.med. PIOTR GĘBSKI
2036971, Specjalista radiolog
Nr Certyfikatu: 403635040163619578319023510984106170908958447247
Certyfikat wystawiony przez Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Wydruk dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.